

مشکلات و اختلالات اضطرابی در کودکان و نوجوانان: راهنمای والدین و مربیان

گردآوری: دکتر محمد ترکمان

تعاریف متعددی از اضطراب وجود دارد، یکی از تعاریف «ترس بیش از حد در موقعیت های واقعی یا تخیلی» است. اگرچه اضطراب و ترس شباهتهای زیادی به هم دارند ولی تفاوت های آنها نیز آشکار است. ترس بر اتفاق ناگوار در حال وقوع یا تجربه ای که به زودی اتفاق خواهد افتاد دلالت دارد، درحالی که اضطراب بر ترسی توجیه ناپذیر دلالت دارد.

مضر یا مفید؟

ویژگی اصلی اضطراب، نگرانی است که عبارت است از دلواپسی بیش از حد درباره موقعیتهای دارای پیامدهای نامطمئن. نگرانی بیش از حد، مضر است چون توانایی انسان در اقدام کردن برای حل مشکل را مختل میکند. از سویی اضطراب پاسخی تکاملی و انطباقی است یعنی همه ی ما برای هوشیاربودن و داشتن عملکرد مؤثر به سطح معینی از اضطراب نیاز داریم. حتی برخی اوقات می تواند موجب بهبود عملکرد فرد بشود. برای مثال، نگرانی درباره امتحان، ما را به مطالعه بیشتر بر می انگیزد یا قبل از یک مسابقه به ما در عملکرد بهتر کمک میکند. اضطراب ملایم حتی به عملکرد هیجان طلبی ما کمک میکند. این امر می تواند توضیح دهد که چرا بعضی از مردم ترن هوایی یا تماشای فیلمهای ترسناک را دوست دارند، چون موجب ایجاد اضطراب در آن ها می شوند. اما اضطراب زیاد باعث درماندگی میشود و موجب اختلال در امور مدرسه، شغل و روابط با دوستانه و خانواده می شود.

در واقع اضطراب در شکل تطابقی خود، به کودکان در سازگاری با دنیای دیگران کمک میکند. میزان متوسط اضطراب دارای عملکرد تنظیمی است و کودکان را برای سازگار کردن رفتارشان با انتظارات اجتماعی، تحصیلی و فرهنگ یاری میدهد. از طرف دیگر اضطراب بسیار کم و بسیار زیاد میتواند عامل ناسازگاری باشد. کسانی که اغلب عملکردهای ضد اجتماعی و مرتبط با سلوک نشان میدهند به احتمال بیشتری، از برانگیختگی اضطراب محروم هستند. اضطراب دائم و بیش از حد نیز باعث ناسازگاری است و منجر به پریشانی شده و در تکامل کودک مداخله می کند.

اختلال اضطرابی در کودکان و نوجوانان

مشکلات مربوط به اضطراب، شایع ترین شکل مشکلات روانشناختی در کودکان و نوجوانان هستند. مطالعات انجام شده در مورد شیوع شناسی این اختلال نشان داده که در حدود ۸ تا ۱۲ درصد کودکان و ۵ تا ۱۰ درصد نوجوانان با یکی از معیارهای تشخیصی اختلال اضطرابی، در حدی که روند زندگی عادی و عملکرد روزانه آنها را مختل نماید، مواجه هستند.

این نوع اضطراب ناسازگارانه را میتوان با توجه به سه ملاک زیر توصیف کرد: الف) بیش از حد شدید باشد. ب) نسبتاً مزمن باشد. ج) مشکلاتی در زندگی والدین و کودک ایجاد کند. اگر چه سه ملاک فوق به طور عملیاتی توصیف نشده، اما می توانند رهنمودهای عملی برای مربیان و درمانگرانی که باید تصمیم بگیرند آیا درمان لازم است یا نه ایجاد کند. اضطرابهایی که این سه ملاک (شدت، تداوم و مزاحمت) را داشته باشند به عنوان اضطراب مرضی از اضطرابهای دوران کودکی متمایز میشوند این درحالی است که دخترها بیشتر از پسرها به اختلالهای اضطرابی دچار می شوند. این مشکلات اغلب از سنین پیش دبستانی شروع و در دبستان نمود رفتاری بیشتری پیدا میکند.

اختلالهای اضطرابی جزو اختلالهای درون نمود هستند. اختلال های درون نمود، علاوه بر اینکه اطرافیان را آزار می دهد، موجب رنجش خود کودک می شود.

مشکلات همراه

اضطراب معمولاً مشکلات دیگری همراه است که از جمله آنها می توان به اختلال های خوردن و سوء مصرف مواد اشاره کرد. کودکان دارای اختلالهای اضطرابی، دارای موقعیتهای تحصیلی پایینتر، مشکلات ارتباط با همسالان و ضعف در تواناییهای اجتماعی هستند. غیبتهای بیش از حد از مدرسه و ارتباط معیوب با همسالان، در آینده منجر به سازگاری شغلی ضعیف و مشکلات مربوط به خود پنداره و همین طور اختلال های روانی در زندگی می شوند.

انواع اختلالات اضطرابی

شکل های معمول اختلال های اضطرابی عبارتند از:

- اختلال اضطراب جدایی که با اضطراب بیش از حد درباره دور بودن از مراقبان اصلی مشخص می شود.
- اضطراب تعمیم یافته که با اضطراب گسترش یافته در اغلب موقعیت های مشخص میشود.
- هراس از مکان های باز
- هراس اجتماعی که شامل اضطراب بیش از حد درباره ی مورد قضاوت قرار گرفتن توسط دیگران یا رفتار در بین جمع است
- اختلالهای هراس که با ترس شدید از اشیاء، حیوانات یا موقعیتهای خاص مشخص میشود، هراس های خاص به گروه وسیعی از ترسها اشاره دارند مانند ترس از حیوانات، ترس از محیط طبیعی، ترس از آمپول و...
- اختلال وحشت زدگی
- اختلال وسواس فکری- عملی که با افکار پایدار و تکرار شونده و رفتارهای قالبی عادی مشخص می شود،
- اختلال استرس پس از آسیب که به دنبال تجربه ی یک حادثه تلخ تکان دهنده مانند بلایای طبیعی، تجاوز جنسی یا مرگ یک عزیز به وجود می آید
- اختلال فشار حاد: گرچه اضطراب ویژگی اصلی تمام این اختلالات است ولی عوامل زمینه ای یا موقعیتی ویژه، میان آنها افتراق میگذارد. آنچه که یک اختلال اضطرابی را از دیگر اختلال ها متمایز می کند کانون اضطراب کودک است

ویژگی های اضطراب در کودکی

هرچند نشانه های اضطراب از نظر نوع و شدت در افراد و موقعیتهای مختلف، متفاوت است، ولی بعضی از نشانه ها در تمام اختلال های اضطرابی مشترک هستند و در پاسخهای شناختی، رفتاری و جسمی ظاهر میشوند. تمامی این نشانه ها در همه ی افراد یا به یک اندازه دیده نمی شوند. از سویی همه ی افراد بعضی مواقع تعدادی از این نشانه ها را نشان میدهند ولی این الزاماً به این معنی نیست که اضطراب وجو دارد و منجر به مشکلاتی میشود.

نشانه های متداول در اختلال های اضطرابی در کودکان		
شناختی	رفتاری	جسمی
اختلال در تمرکز	کم رویی	لرزیدن
واکنش بیش از حد به رویداد های کم اهمیت	کناره گیری	افزایش ضربان قلب
اختلال در حافظه	نیاز دایم به اطمینان خاطر دوباره	عرق کردن بیش از حد
نگرانی	پرسش مکرر سؤال	کوتاه بودن تنفس
زودرنجی	نیاز به اجتناب از شباهت	سرگیجه و تاری دید
کمال گرایی	تند حرف زدن	درد یا ناراحتی در قفسه ی سینه
تفکر جزئی	صحبت بیش از حد	سرخ شدن صورت
گوش به زنگی افراطی	ناآرامی و بی قراری	تهوع، استفراغ، اسهال
ترس از دست دادن کنترل	عادات رفتاری مثل کشیدن یا پیچاندن مو	گرفتگی عضلانی
ترس از شکست	شتابزدگی	اختلال در خواب
اختلال در حل مسئله و عملکرد تحصیلی		
هابرتی، تی. جی. (۲۰۱۰). اضطراب و اختلال های اضطرابی در کودکان: اطلاعاتی برای والدین. انجمن ملی روان پزشکان مدرسه: دانشگاه ایندیانا.		

سبب شناسی اضطراب کودکی

عوامل ژنتیکی و ارثی

بررسی نقش ژنتیک در اختلال های اضطرابی نقش عوامل ارثی را معنی دار اما در حد متوسط نشان می دهد. مطالعات خانوادگی نشان اده اند که فرزندان بیلوژیک والدین مبتلا به اختلالهای اضطرابی بیشتر در معرض ابتلاء به اضطراب جدایی در دوران کودکی هستند. والدین مبتلا به اختلال هراس و گذرهراسی به احتمال بیشتری کودک مبتلا به اختلال اضطراب جدایی دارند.

عوامل زیست شناختی و جسمی

بر اساس یافته های حاصل از پژوهش های صورت گرفته در حوزه نوروبیولوژی، مشخص شده که مدرات خاصی از مغز بستر ساز بروز اضطراب در آدمی میشوند. برای مثال آمیگدال (بادامه مغز) به سرعت به محرکهای بالقوه خطرناک پاسخ ادهو به طریق شیمیایی سبب میشود که بدن بلافاصله واکنش نشان دهد. در افراد مضطرب میزان بعضی از هورمونهای موجود در خون غیرعادی است. نابراین هر چه که باعث اختلال در سیستم هورمونی شود، مانند کم کاری یا پرکاری تیروئید، یا پایین بودن قند خون، برای بدن خطر محسوب میشود.

عوامل محیطی و تربیتی

پژوهشهای قابل توجهی عوامل که مربوط کودک می شوند را شناسایی کرده اند که موجب ایجادو حفظ نشانه های اضطراب در کودک میشود. والدین مضطرب، ترس و اضطراب ر الگوسازی میکنند، رفتار اضطرابی را تقویت میکنندو علی رغم تمایل شان به کمک به کودک، ناآگاهانه موجب حفظ رفتارهای اجتنابی می شوند. سبکهای فرزندپروری بیش از حد حمایت کنده، بیش از حد کنترل کنده و بیش از حد انتقادی که جلو رشد خودمختاری و مهارت آموزی را می گیرند نیز منجر به شکل گیری اختلالهای اضطرابی در کودکان می شود. همچنین دلبستگی غیرقابل اطمینان به مراقبان می تواند خطر ابتلا به اضطراب کودکی ر افزایش دهد. فزون بر این، عوامل اجتماعی و ارتباطی بسیاری باعث به وجود آمدن اضطراب در افراد می شود، مانند مشکلات خانوادگی، احساس جدایی و طرد شدگی و .. از عوامل محیطی می توان تغییرات ناگهانی و غیر منتظره همچون زلزله، بیماری، مرگ یکی از عزیزان و غیره را نام برد.

مداخله

رفتار تحت تأثیر پیش آیندها و پیامدهاست. پیامدهایی که احتمال وقوع رفتار افزایش میدهند، تقویت کننده نامیده میشوند. بنابراین با تغییر پیش آیندها و پیامدها میتوان تغییراتی در رفتار به وجود آورد. مثلاً وقتی کودک بخاطر اضطراب به والدین فشار می آورد که به میهمانی نروند، والدین با نرفتن رفتار اضطرابی کودک را تقویت میکنند که باید در این زمینه مداخله کنند. از منظر دیگر، بیشتر رفتار تحت کنترل افکار یا الگوهای ذهنی است تأکید میکند. به این ترتیب، تغییر خودگویی کودک (که در کودکان مضطرب اغلب منفی است) میتواند به رشد تکنیک های خودکنترلی مناسبتر منجر شود. تکنیک های زیر نیز کمک کننده است:

✓ آموزش به کودک والدین درباره اضطراب (بهخصوص تشخیص اضطراب طبیعی و غیرطبیعی)

✓ تمرینهای آرمیدگی عضلانی پیش رونده

✓ تکنیکهای تنفس عمیق

✓ به چالش طلبیدن افکار اضطراب انگیز (بازسازی شناختی)

✓ قرار دادن کودک در معرض موقعیت های اضطراب -انگیز (تخیلی واقعی)

راهبرد ۴ گام

در این برنامه ۴ گام راهبردی ارائه میشود. چهار حرف طرح FEAR هر یک معرف یک مرحله هستند که در زیر به اختصار توضیح داده میشوند:

F شناسایی احساسات اضطراب

در ابتدا فرد باید یاد بگیرد بین احساسات اضطراب یا نگرانی از دیگر احساسات تمایز قایل شود. حالات چهره به عنوان نشانه هایی از احساسات افراد عمل می کند؛ علاوه بر این بدن افراد نیز در پاسخ به احساسات متفاوت کارهای متفاوتی انجام می دهد. اولین مرحله از طرح FEAR در مدیریت اضطراب بررسی بدن و پرسیدن این سؤال از خود است که آیا من عصبی هستم. فرد باید در شناسایی نشانه هایی که بدنش به او می فرستد آموزش ببیند. یکی از اولین راهبردهایی که فر در مدیریت اضطراب می آموزد، آرمیده کردن بدن است. تنش می تواند با آرمیدگی کاهش پیدا کند. آرام سازی منظم از طریق آموزشهای دقیق در مورد چگونگی ایجاد تعدیل تنش در ماهیچه های مختلفو چگونگی آرام سازی به آن ها آموخته میشود. همراه کردن تن آرامی با آموزش تجسم صحنه های اضطراب زا که در طی حساسیتزدایی منظم روی می دهد، هم برانگیختگی غیرعادی را بازداري میکند و هم پاسخ جدیدی را برای شرطی شدن با محرکهای اضطراب زای گذشته فراهم میکند تکنیکهای متنوعی برای آرمیدگی وجود دارد که متداولترین آنها تنفس عمیقو آرمیدگی عضلانی پیشرونده است.

E نقش خودگویی اضطرابی

مرحله دوم از طرح FEAR بررسی خودگوییهای فرد است. در این مرحله که بخش مهمی از برنامه است، فرد بررسی میکند که آیا انتظار دارد اتفاقات بدی بیافتد. درمانگر با کودک یا نوجوان کار می کند تا به او کمک کند افکار اضطراب آور خود را مورد کاوش قرار

دهد. در این درمان فرد یاد می گیرد که خود گویی های اضطرابی (مثل، من نمیتوانم این کار را انجام دهم. من همیشه افتضاح بار می آورم) را با خود گویی های مقابله ای (مثل، بدترین چیزی که ممکن است اتفاق بیافتد چیست، من این کار را قبلاً هم انجام داده ام پس باز هم میتوانم) عوض کند.

A نگرشها و اقدامات مفید

مرحله سوم در طرح FEAR نگرشها و اقداماتی هستند که می توانیم برای داشتن احساس بهتر برگزینیم. در این مرحله فرد می آموزد که چطور واکنش هایش را اصلاح کند یا حتی با وجود احساس اضطراب پیش برود. فرد یاد می گیرد برای به چالش کشیدن خود گویی اتفاق خواهد افتاد؟ مثالی از افکار مقابلهای عبارتند از: مهم تلاش کردن است؛ هیچ کس کامل نیست؛ همه اشتباه می کند؛ قبلاً این کار را کرده ام باز هم میتوانم.

R پیامدها و پاداشها

مرحله آخر در طرح ج مربوط به پیامدها و پاداشها است. پاداشها به خاطر تلاش داده میشوند حتی اگر همه چیز طبق برنامه پیش نرود. بعضی اوقات پاداشها از جانب دیگران هستند (مثل کسب مدال یا جایزه در یک مسابقه) و بعضی وقتها ما به خودمان پاداش می دهیم (مانند تماشای فیلم مورد علاقه یا صحبت تلفنی با یک دوست). در برنامه بر دادن پاداش به خاطر تلاش و موفقیت جزئی تأکید میشود. پاداشها به انسان انگیزه میدهند. میتوان در ابتدای برنامه با کمک کودک یا نوجوان فهرستی از پاداشها را تهیه کرد و در حین پیشرفت برنامه به او داد. لازم به ذکر است که کودک یا نوجوان در هنگام مواجهه با موقعیتهای چالش انگیز اضطراب را تجربه خواهد کرد. این اضطراب قابل انتظار و سودمند است و به کودک یا نوجوان فرصت میدهد مجموعه مهارتهای آموخته شده را به کار ببندد و موفقیت را تجربه کند. در تکالیف تمرینی فرد برای مدت معینی در موقعیت اضطراب آور میماند تا دریابد که می تواند با موقعیت که برای کودک یا نوجوان اضطراب آور هستند مقابله کند. کودک با همکاری درمانگر یا والدین به موقعیت هایی کند و این موقعیتهای را روی یک هرم به نام هرم ترس یا نردبان ترس قرار میدهند که در آن موقعیت هایی که که اضطراب زیادی تولید میکند در بالای هرم ثبت میشود اضطراب کمتری ایجاد میکند در پایین و موقعیتهایی شوند. در طول برنامه کودک یا نوجوان به سمت بالای هرم حرکت میکند.

سه روش مهم دیگر

قصه گویی

ریچارد گاردنر تکنیک قصه گویی متقابل را به عنوان ابزاری درمانی در کار با کودکان مطرح کرد. در این تکنیک از شیوه مشابهی نیز بهره گرفته می شود تا به کودکان کمک شود افکار و احساسات خویش را درک کنند و نیز بینش ها، ارزش ها و معیارهای رفتاری معناداری به کودکان تفهیم شود. مشاور مقدمات را فراهم می کند و از کودک می خواهد شروع به گفتن قصه کند که البته ضبط نیز می شود مشاور به کودک می آموزد که هر داستان باید شروع، متن داستان و پایانی داشته باشد و در آخر جلسه نیز از او در باره ی نتیجه ی اخلاقی داستان سؤال می شود. پس از آنکه کودک قصه را تمام کرد، مشاور ممکن است لازم بداند بعضی قسمتهای داستان را توضیح دهد. آنگاه مشاور با استفاده از موضوع و زمینه ی مشابه از جمله گرفتن شخصیتهای مهم داستان کودک، داستانی

را آماده میکند. با وجود این، داستان مشاور راه حل های بهتر یا پاسخ هایی مناسب تر برای وضعیت یا مشکل مورد نظر پیش پای کودک می گذارد.

بازیهای تخیلی

بازیهای تخیلی میتوانند برای کودکان دارای سنین مختلف بسیار سرگرم کننده باشند و آنان را از احساسات کنونی شان آگاه سازند. کودکان در یک بازی تخیلی گروهی، حیوانی را انتخاب میکنند که دوست دارند آن حیوان میبوند و همان کارهایی را میکردند که حیوان مزبور میکند. در این بازی، کودکان دو نفری با هم مینشینند و با هم در این باره بحث و گفتگو میکنند که اگر آن حیوان خاص میبوند، چه احساسی داشتند. در اوج و مرحلهی نهایی این بازی، آنان می توانند داستانی در اینباره بنویسند که اگر واقعاً آن حیوان میبوند چه احساسی داشتند. در آخر تمرین و بازی، کودکان آگاهی واقع بینانه تری از چگونگی احساس خویش پیدا میکنند و بهتر میتوانند دربارهی احساسشان با مشاور، معلم یا پدر و مادرشان صحبت کنند.

در معرض تدریجی قرار دادن

علت اصلی تأثیر گذاری این برنامه "در معرض قرار دادن تدریجی" آن است. در معرض قرار دادن تدریجی شامل کمک به کودک برای برداشتن گام های کوچک به سمت آن چه از آن میترسد و در عین حال کاهش رفتارهای اجتنابی است. رفتارهای اجتنابی رفتارهایی هستند که کودکان برای کاهش اضطراب از آنها استفاده می کنند، این رفتارها هرچند ممکن است به طور موقتی اضطراب را کاهش دهند ولی موجب افزایش اضطراب در دراز مدت می -شوند. در تکنیک در معرض قرار دادن موقعیت های ترسناک به طور سلسله مراتبی تنظیم میشوند، به طوری که کودک ابتدا در موقعیتهایی که کمترین میزان اضطراب را برمی انگیزد قرار اده میشود و به تدریج با موقعیت های ترس آور مواجه می شود

نکته آخر

از آنجایی که والدین احساسات عمیقی نسبت به فرزندشان دارند مکن است از دیدن نگرانی فرزندشان ناراحت شوند، اما بهترین کاری که میتوانند انجام دهند آن است که به فرزندشان کمک کند با ترسش روبه رو شود. در مجموع چنین نتیجه میشود که برنامه فوق از جهت اینکه جنبه پیشگیرانه و مداخله سطحی دارد، در مورد اختلالهای اضطرابی خفیف بهتر است. اما در مورد اختلالات اضطرابی شدید لازم است یک روانشناس کودک پس از ارزیابی های لازم مداخله موثر را انجام دهد و شاید نیاز به دارو نیز احساس شود. یکی از فنونی که در مراکز مشاوره استفاده میشود بازی درمانی میباشد. فرض را براین میگذارد که کودکان وقتی دنیا و رابطه شان با آن را در بازی دوباره خلق کنند می توانند مشکلات خود را حل کنند. بازی به ویژه در مورد کودکان خردسالی که گستره توجه کمی دارند، یا کودکانی که در بیان و توصیف کلامی خود مشکل دارند، یا کودکانی که به رسش رشدی یا هیجانی نرسیده اند، میتواند مفید باشد. استفاده از بازی در مورد این کودکان به آنها آزادی عمل می دهد و از فشار بر آنها میکاهد. بازی، ارتباط را تسهیل میکند و به مشاور یا درمانگر کمک می کند به دنیای کودک وارد شود.

یک کتاب

کلیدهای مقابله با اضطراب در کودکان و نوجوانان. نوشته دکتر کاتارینا ماناسیس. ترجمه فرناز فرود. نشر کتابهای دانه.